

Mapa da Fertilidade

Exemplo Baixa · 30 de junho de 2026



Classificação: FERTILIDADE BAIXA

Seu corpo não está falhando. Ele está falando. E agora você pode finalmente ouvir com clareza onde estão os bloqueios que precisam ser cuidadosos.

12

PONTOS DE 285

13

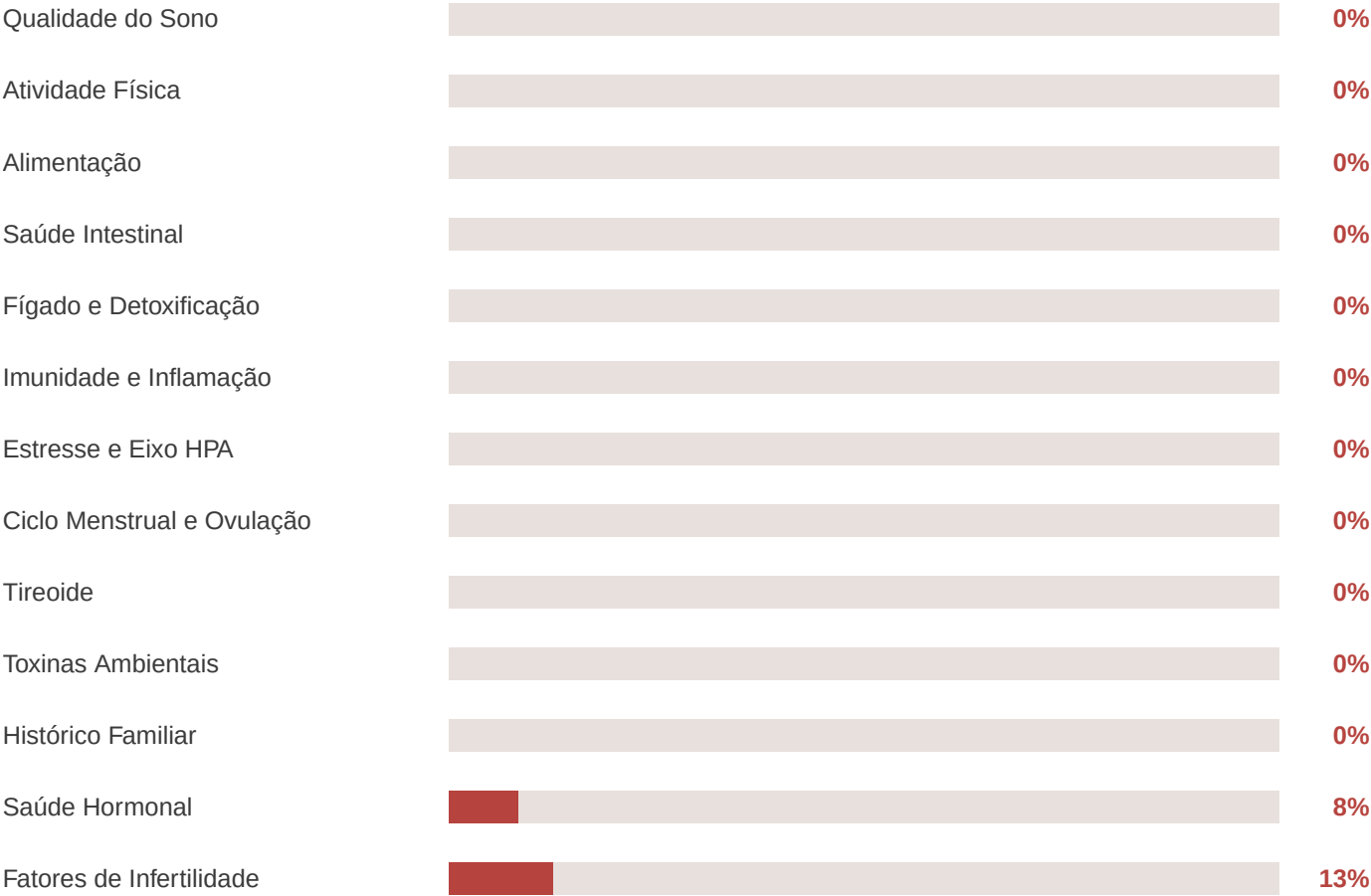
PILARES AVALIADOS

10

PONTOS DE ATENÇÃO

Visão geral por categoria

Os 13 pilares avaliados, ordenados do que mais precisa de atenção para o que já está mais consolidado. Use este panorama para decidir por onde começar — o detalhamento de cada pilar vem nas próximas páginas.



Pontos de atenção específicos

Identificados a partir de respostas específicas suas — aparecem aqui independentemente da sua classificação geral, porque merecem atenção mesmo quando o restante do seu mapa está equilibrado.



ALERTA CLÍNICO

SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos)

Você indicou suspeita ou diagnóstico confirmado de SOP. A SOP pode interferir diretamente na ovulação mesmo quando outros marcadores de fertilidade estão bons — vale priorizar acompanhamento com ginecologista/endocrinologista especializado, independentemente do seu resultado geral.



ALERTA CLÍNICO

Endometriose

Você indicou suspeita ou diagnóstico confirmado de endometriose. Essa condição pode afetar a fertilidade de forma silenciosa e merece investigação e acompanhamento dedicados, mesmo que o restante do seu mapa esteja equilibrado.



PONTO DE ATENÇÃO

Idade reprodutiva

Sua faixa etária está associada a uma queda natural na reserva ovariana. Isso não impede uma gestação, mas reforça a importância de não adiar exames como AMH e contagem de folículos antrais, e de buscar avaliação especializada caso a tentativa de engravidar já esteja em curso.



ALERTA CLÍNICO

Doença autoimune

Você indicou ter uma doença autoimune (como Hashimoto ou Lúpus). Condições autoimunes podem impactar a fertilidade e merecem acompanhamento conjunto com seu especialista, alinhado ao seu plano de fertilidade.



ALERTA CLÍNICO

Obstrução tubária

Você indicou histórico de obstrução nas trompas. Esse é um fator mecânico de infertilidade que, dependendo do grau, pode exigir avaliação para concepção natural versus técnicas assistidas — converse com seu especialista em reprodução sobre os próximos passos.



PONTO DE ATENÇÃO

Peso corporal

Seu IMC está fora da faixa associada à fertilidade ideal. Tanto o excesso quanto a magreza severa podem alterar a produção hormonal e a ovulação — um acompanhamento nutricional pode ajudar a reequilibrar esse pilar.

**ALERTA CLÍNICO****TSH alterado**

Seu TSH está fora da faixa ideal (acima de 3,5). Alterações tireoidianas têm relação direta com regularidade do ciclo e ovulação — vale uma reavaliação endócrina específica para esse marcador.

**ALERTA CLÍNICO****Ausência de ovulação confirmada**

Suas respostas indicam ciclo ausente e/ou ausência de ovulação confirmada. Esse é um dos sinais mais diretos de alerta para fertilidade e merece investigação prioritária com ginecologista.

**PONTO DE ATENÇÃO****Esteatose hepática**

Você indicou diagnóstico de esteatose hepática moderada ou grave. A sobrecarga no fígado interfere na metabolização de hormônios (incluindo o estrogênio) e pode impactar indiretamente a fertilidade — esse ponto merece atenção em paralelo ao restante do plano.

**PONTO DE ATENÇÃO****Doença autoimune confirmada**

Você confirmou uma doença autoimune com impacto no seu sistema imunológico. Isso reforça a importância de manter o acompanhamento médico já em curso em paralelo às recomendações deste relatório.

Detalhamento por pilar

Os mesmos 13 pilares do panorama anterior, agora organizados por tema e com a análise completa de cada um.

Fatores Clínicos

Os pilares mais diretamente ligados ao diagnóstico médico da sua fertilidade — onde exames e acompanhamento especializado fazem mais diferença.



Fatores de Infertilidade

Baixo

Vários marcadores alterados – como idade elevada, diagnósticos confirmados (SOP, endometriose) ou IMC fora da faixa ideal.

RECOMENDAÇÃO

Reavaliação com especialista em reprodução + abordagem integrativa com endocrinologista e nutricionista funcional.



Saúde Hormonal

Baixo

FSH, AMH ou progesterona estão abaixo do ideal.

RECOMENDAÇÃO

Suplementação direcionada e estratégia alimentar rica em colina, gorduras boas, vitamina D3, selênio e zinco.



Ciclo Menstrual e Ovulação

Baixo

Ciclo ausente ou sem ovulação confirmada.

RECOMENDAÇÃO

Rastreamento com testes de temperatura e mucos; suplementos.



Tireoide

Baixo

TSH alterado (>2,5) indicando disfunção.

RECOMENDAÇÃO

Exames completos e suporte nutricional com selênio natural.

Estilo de Vida

Hábitos do dia a dia que você consegue ajustar com mais autonomia, e que têm efeito direto sobre o equilíbrio hormonal.



Qualidade do Sono

Baixo

Sono fragmentado, curto ou agitado.

RECOMENDAÇÃO

Estabeleça rotina noturna com luz baixa, evite telas 1h antes de dormir e use infusões calmantes.



Atividade Física

Baixo

Sedentarismo ou exercício isolado e não adaptado.

RECOMENDAÇÃO

Comece com caminhadas diárias + alongamento e yoga hormonal.

**Alimentação**
Baixo

Alta presença de industrializados e baixo consumo de fibras, vegetais e proteínas.

RECOMENDAÇÃO

Dieta anti-inflamatória com vegetais frescos, sementes, ovos caipiras e carnes magras.

**Estresse e Eixo HPA**
Baixo

Alta exaustão mental, insônia ou ansiedade.

RECOMENDAÇÃO

Pausas diárias, terapia e atividades prazerosas.

Corpo e Equilíbrio Interno

Como seu corpo processa, absorve e se protege — a base fisiológica que sustenta todos os outros pilares.

**Saúde Intestinal**
Baixo

Evacuação irregular, gases e histórico de disbiose.

RECOMENDAÇÃO

Uso de probióticos, fibras solúveis e redução de FODMAPs; introduza fermentados.

**Fígado e Detoxificação**
Baixo

Sinais de sobrecarga (TPM intensa, acne, cansaço).

RECOMENDAÇÃO

Detox suave, vegetais amargos e suplementos hepáticos.

**Imunidade e Inflamação**
Baixo

Inflamação moderada a alta (sintomas ou exames).

RECOMENDAÇÃO

Reduza açúcares e ultraprocessados; inclua antioxidantes.

**Toxinas Ambientais**
Baixo

Alta exposição a toxinas domésticas.

RECOMENDAÇÃO

Detox do lar, cosméticos limpos e utensílios de vidro/inox.

**Histórico Familiar**
Baixo

Histórico familiar de infertilidade presente.

RECOMENDAÇÃO

Proatividade em exames e compartilhamento de histórico.

Seu plano de ação

Uma síntese do que priorizar agora, juntando os pontos de atenção específicos com os pilares que mais precisam de cuidado — começando pelo mais urgente.

- 1 SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos)**
Você indicou suspeita ou diagnóstico confirmado de SOP. A SOP pode interferir diretamente na ovulação mesmo quando outros marcadores de fertilidade estão bons — vale priorizar acompanhamento com ginecologista/endocrinologista especializado, independentemente do seu resultado geral.
- 2 Endometriose**
Você indicou suspeita ou diagnóstico confirmado de endometriose. Essa condição pode afetar a fertilidade de forma silenciosa e merece investigação e acompanhamento dedicados, mesmo que o restante do seu mapa esteja equilibrado.
- 3 Doença autoimune**
Você indicou ter uma doença autoimune (como Hashimoto ou Lúpus). Condições autoimunes podem impactar a fertilidade e merecem acompanhamento conjunto com seu especialista, alinhado ao seu plano de fertilidade.
- 4 Obstrução tubária**
Você indicou histórico de obstrução nas trompas. Esse é um fator mecânico de infertilidade que, dependendo do grau, pode exigir avaliação para concepção natural versus técnicas assistidas — converse com seu especialista em reprodução sobre os próximos passos.
- 5 TSH alterado**
Seu TSH está fora da faixa ideal (acima de 3,5). Alterações tireoidianas têm relação direta com regularidade do ciclo e ovulação — vale uma reavaliação endócrina específica para esse marcador.
- 6 Ausência de ovulação confirmada**
Suas respostas indicam ciclo ausente e/ou ausência de ovulação confirmada. Esse é um dos sinais mais diretos de alerta para fertilidade e merece investigação prioritária com ginecologista.

Este relatório é um retrato do momento atual a partir das suas respostas — não um diagnóstico. Leve-o para sua próxima consulta como ponto de partida para uma conversa mais direcionada com seu médico ou especialista.